

# Bàng Quang Mới Tại Chỗ

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Bàng quang mới làm từ ruột, giúp bạn tự đi tiểu bình thường

Bàng quang mới tại chỗ là bàng quang được tạo từ một đoạn ruột của chính bạn và nối với niệu đạo, cho phép bạn đi tiểu theo cách tự nhiên — không cần túi — sau khi bàng quang được cắt bỏ hoặc không còn hoạt động. Cần có thời gian và luyện tập để làm quen cách làm trống bàng quang và kiểm soát tiểu tiện.

## Về ca phẫu thuật này

Khoảng **40–60 cm ruột non** được lấy ra, mỡ dọc và khâu thành một túi chứa áp lực thấp, sau đó nối với **niệu đạo**; các niệu quản (ống dẫn từ thận) được nối vào túi. **Không có lỗ thông và không cần túi ngoài cơ thể.**

Vì bàng quang mới làm từ ruột, nó **không** gửi tín hiệu “buồn tiểu” như bình thường, nên bạn cần học cách:

- Đi tiểu theo **lịch cố định** — bằng cách thư giãn sàn chậu và rặn nhẹ — kể cả **thức dậy ban đêm**.
- Tự thông tiểu để làm trống bàng quang nếu không thoát hết (phổ biến hơn ở phụ nữ).
- Tập **bài tập cơ sàn chậu** để cải thiện kiểm soát.

Khả năng kiểm soát cải thiện dần trong **nhiều tháng**; rò rỉ nước tiểu, đặc biệt ban đêm, thường gặp ở giai đoạn đầu. Không phải ai cũng phù hợp — tùy thuộc vào niệu đạo, chức năng thận và khả năng tuân thủ theo dõi.

## Có an toàn không?

Đây là phương pháp được công nhận rộng rãi, cho kết quả “tự nhiên” nhất. Cuộc mổ lớn hơn và dài hơn so với dẫn lưu qua hồi tràng, đòi hỏi nhiều học tập và chăm sóc sau mổ. Rủi ro gồm: biến chứng phẫu thuật (chảy máu, nhiễm trùng, rò), rò rỉ nước tiểu ban ngày hoặc ban đêm, không làm trống hết cần tự thông, chất nhầy, nhiễm trùng tiểu, và thay đổi muối/vitamin/thận cần theo dõi lâu dài.

## GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

### Bàng quang mới (Neobladder)

Bàng quang mới tạo từ một đoạn ruột.

### Tại chỗ (Orthotopic)

Đặt đúng vị trí bình thường và nối với niệu đạo, để bạn đi tiểu theo cách thông thường.

### Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.

### Niệu quản

Ống dẫn nước tiểu từ thận; được nối vào bàng quang mới.

### Đi tiểu theo giờ

Đi tiểu theo lịch cố định (ngày và đêm) thay vì chờ cảm giác buồn tiểu.

### Tự thông tiểu

Tự đặt ống thông mảnh để làm trống bàng quang mới khi cần.

### Sàn chậu

Nhóm cơ luyện tập để kiểm soát việc giữ và thả nước tiểu.

### Chất nhầy

Dịch nhớt do ruột tiết ra; thấy sợi nhầy trong nước tiểu là bình thường.

**CÓ ĐAU KHÔNG?** Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, bụng sẽ đau nhức và ruột cần vài ngày để “hoạt động trở lại.” Bạn sẽ thức dậy với ống thông trong bàng quang mới (để khoảng 2–3 tuần) cùng với ống đỡ mềm. Hầu hết bệnh nhân nằm viện khoảng 5–8 ngày; cuộc mổ khá dài.

## Cách chuẩn bị (Trước khi phẫu thuật)

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân** — tuân thủ mọi hướng dẫn phẫu thuật (nhịn ăn, ngừng thuốc loãng máu theo chỉ dẫn). Có thể cần **chuẩn bị ruột**.
- Hiểu rõ cam kết: **đi tiểu theo giờ ngày và đêm**, có thể cần **tự thông tiểu**, và tập bài tập cơ sàn chậu.
- Không hút thuốc** và thu xếp người hỗ trợ tại nhà sau mổ.

### Báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc loãng máu** hoặc đang bị nhiễm trùng
- Có **bệnh lý đường ruột**, vấn đề thận, tiền sử phẫu thuật bụng hoặc xạ trị

## Quá trình phẫu thuật

- Bạn được gây mê và dùng kháng sinh.
- Một đoạn ruột được tách ra; phần còn lại được nối lại.
- Đoạn ruột được mở dọc và khâu thành túi chứa, rồi nối với niệu đạo.
- Niệu quản được nối vào túi; đặt ống thông và ống đỡ mềm trong thời gian lành thương.

## Sau khi phẫu thuật

- Bạn về nhà sau khoảng **5–8 ngày** với **ống thông trong ~2–3 tuần**; có thể bơm rửa để thông chất nhầy.
- Chụp **X-quang kiểm tra** bàng quang mới trước khi rút ống thông.
- Sau đó bạn học **đi tiểu theo giờ** (đặt báo thức ban đêm), tập cơ sàn chậu, và **tự thông tiểu** nếu không làm trống hết.
- Chờ đợi **rò rỉ ban đầu** (đặc biệt ban đêm) cải thiện dần theo tháng. Chất nhầy là bình thường; uống đủ nước; theo dõi suốt đời (gồm vitamin B12).

### Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Không thể đi tiểu** hoặc ống thông **ngừng chảy**
- Đau bụng dữ dội, nôn ói, hoặc **không có hơi hay phân**
- Chảy máu nhiều, vết thương đỏ hoặc chảy dịch, hoặc đau hông lưng

## BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Bàng quang mới được tạo từ ruột và nối với niệu đạo, giúp bạn đi tiểu tự nhiên không cần túi ngoài.
- Cần luyện tập: đi tiểu theo giờ ngày và đêm, tập cơ sàn chậu, và đôi khi tự thông tiểu. Khả năng kiểm soát cải thiện dần; rò rỉ ban đầu là bình thường.
- Chuẩn bị bằng cách nhịn ăn và chuẩn bị ruột theo hướng dẫn, không hút thuốc. Giữ ống thông cho đến khi nhóm chăm sóc rút sau khi chụp X-quang kiểm tra, và gọi ngay nếu không thể đi tiểu hoặc ống thông ngừng chảy.